BỆNH NGUYÊN BÀO NUÔI THAI KỲ
(Gestational trophoblastic disease)

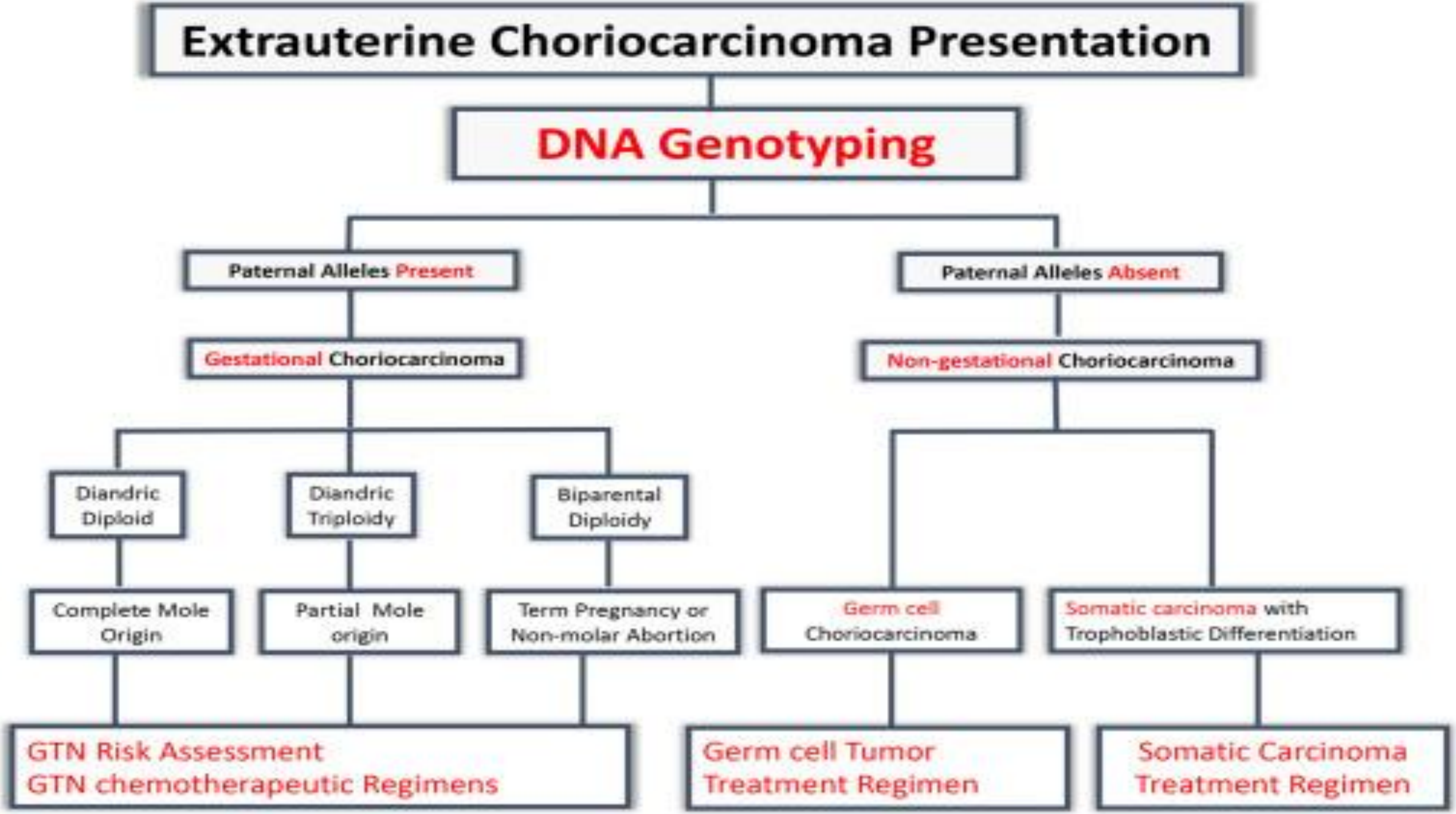
Ths Bs: Lê Đoàn Vũ

Định nghĩa

Bệnh nguyên bào nuôi thai kỳ (Gestational trophoblastic disease – GTD): tăng sinh của nguyên bào nuôi (**bánh nhau**), dấu chỉ đặc trưng βhCG

Bệnh nguyên bào nuôi không liên quan đến thai kì (non- gestational choriocarcinoma)

- DNA khối u cùng bệnh nhân
- Đáp ứng kém với hóa trị liệu, tiên lượng xấu
- Không có DNA của bố


Extrauterine Choriocarcinoma Presentation
DNA Genotyping
Paternal Alleles Present
Paternal Alleles Absent
Gestational Choriocarcinoma
Non-gestational Choriocarcinoma
Diandric Diploid
Diandric Triploidy
Biparental Diploidy
Complete Mole Origin
Partial Mole origin
Term Pregnancy or Non-molar Abortion
Germ cell Choriocarcinoma
Somatic carcinoma with Trophoblastic Differentiation
GTN Risk Assessment
GTN chemotherapeutic Regimens
Germ cell Tumor Treatment Regimen
Somatic Carcinoma Treatment Regimen

Đặc điểm	Gestational choriocarcinoma	Non-gestational choriocarcinoma
Nguồn gốc tế bào	50% thai trứng, 25% sau sẩy thai, thai lưu, 25% thai đủ tháng, non tháng	Tế bào mầm: Sinh dục (Buồng trứng, tinh hoàn)/ ngoài sinh dục (Phúc mạc sau, trung thất, thần kinh trung ương) Tế bào soma: Phổi, đường tiêu hóa, đường tiết niệu
Gen từ cha	Có	Không có
Di căn	Chủ yếu đường máu, hiếm khi qua bạch huyết	Tế bào mầm: bạch huyết và ổ bụng Tế bào soma: bạch huyết và máu
Đáp ứng hóa trị	Tốt	Kém
Tiên lượng	Tốt	Xấu

Phân loại

- Thai trứng (molar pregnancies): Toàn phần (complete) và Bán phần (partial)
- U nguyên bào nuôi (trophoblastic tumors)/ tân sinh nguyên bào nuôi (Gestational trophoblastic neoplasia- GTN)
  - Thai trứng xâm lấn (invasive mole)
  - Choriocarcinoma
  - U nguyên bào nuôi tại vị trí nhau bám (Placental site trophoblastic tumors- PSTT)
  - U nguyên bào nuôi dạng biểu mô (Epithelioid trophoblastic tumors- ETT)

Thai trứng

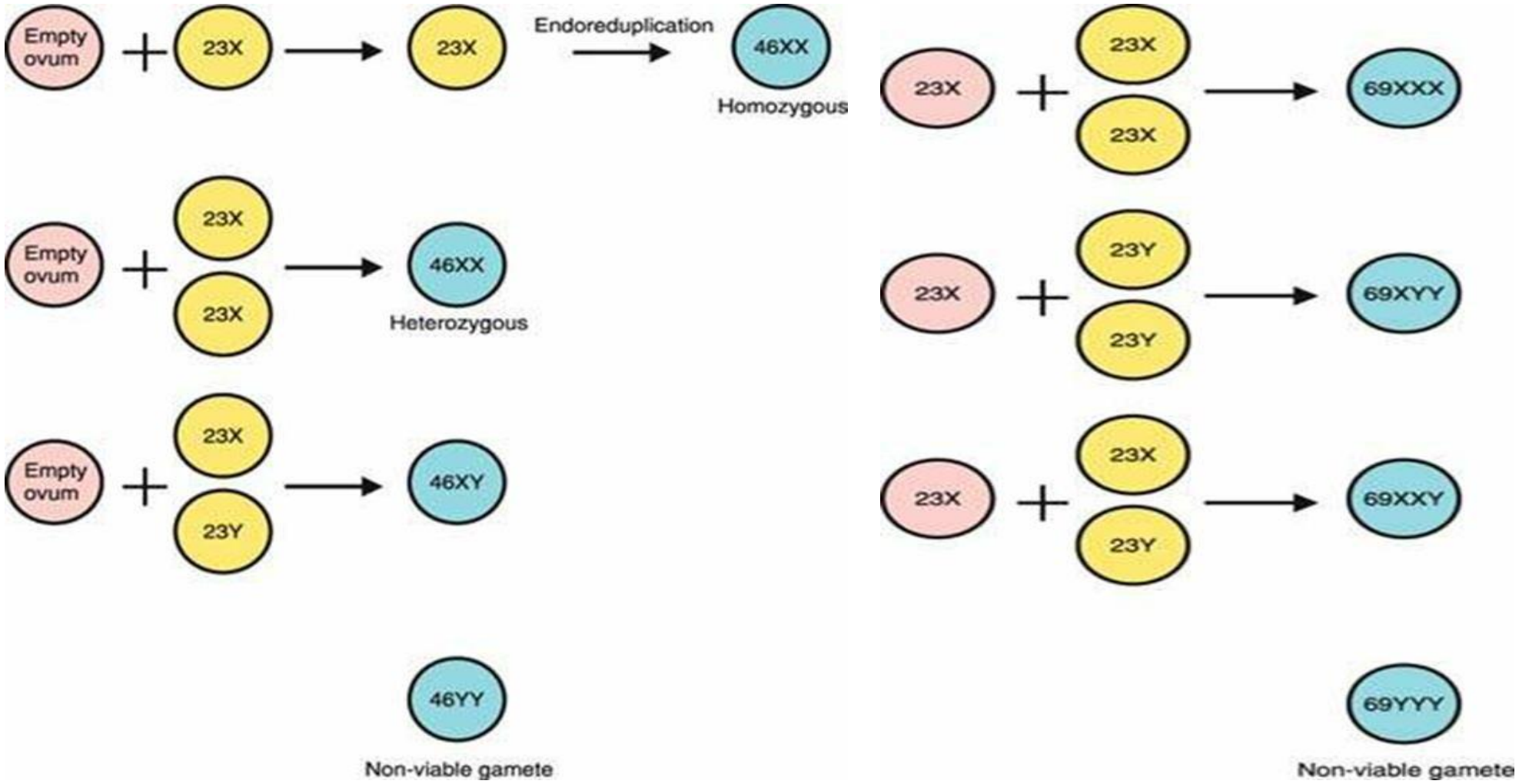
- Tăng sinh bất thường các tế bào nuôi
- Dạng lành tính của nguyên bào nuôi
- Biến chứng: Nhiễm trùng, xuất huyết, ung thư nguyên bào nuôi

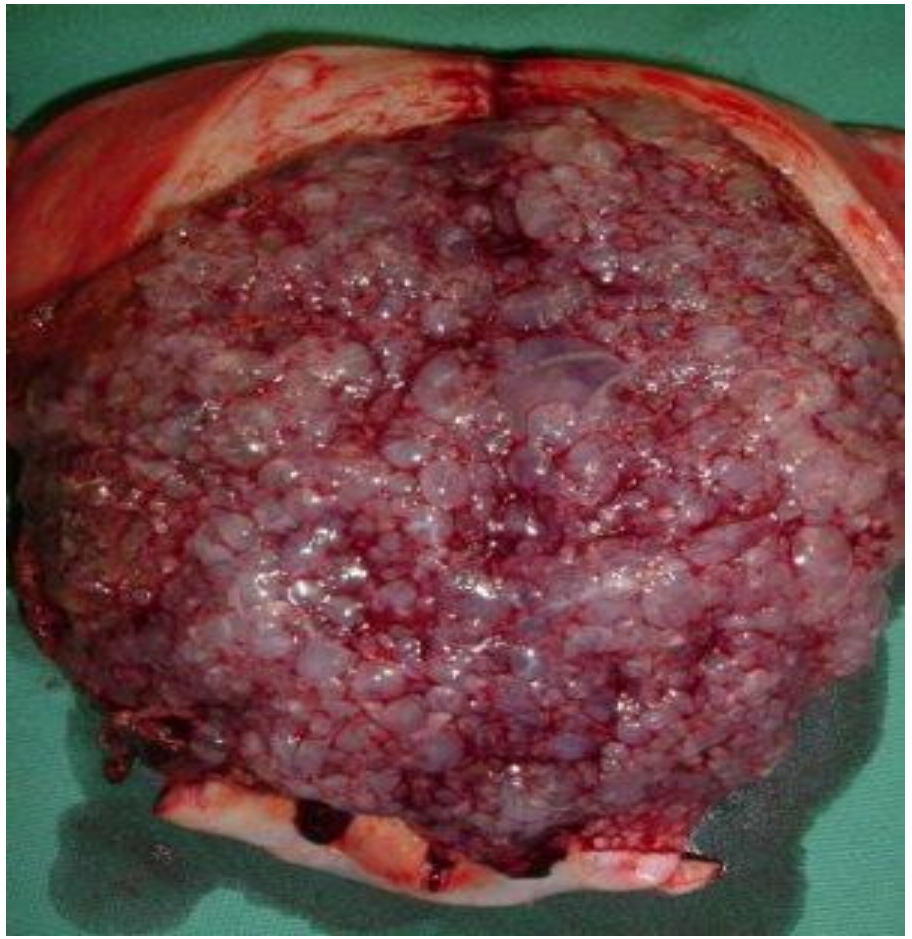
Tỉ suất

Quốc Gia/vùng	Tỷ Lệ
Mỹ	1/1500 thai nghén
Nhật	1/522 thai nghén
Pháp	1/2000 thai nghén
Philippine	7/1000 trường hợp sinh
Malaysia	2,8/1000 trường hợp sinh
Việt nam Hà Nội (Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh) TP Hồ Chí Minh (Bệnh viện Từ Dũ)	 1/500 trường hợp sinh 1/100 trường hợp sinh

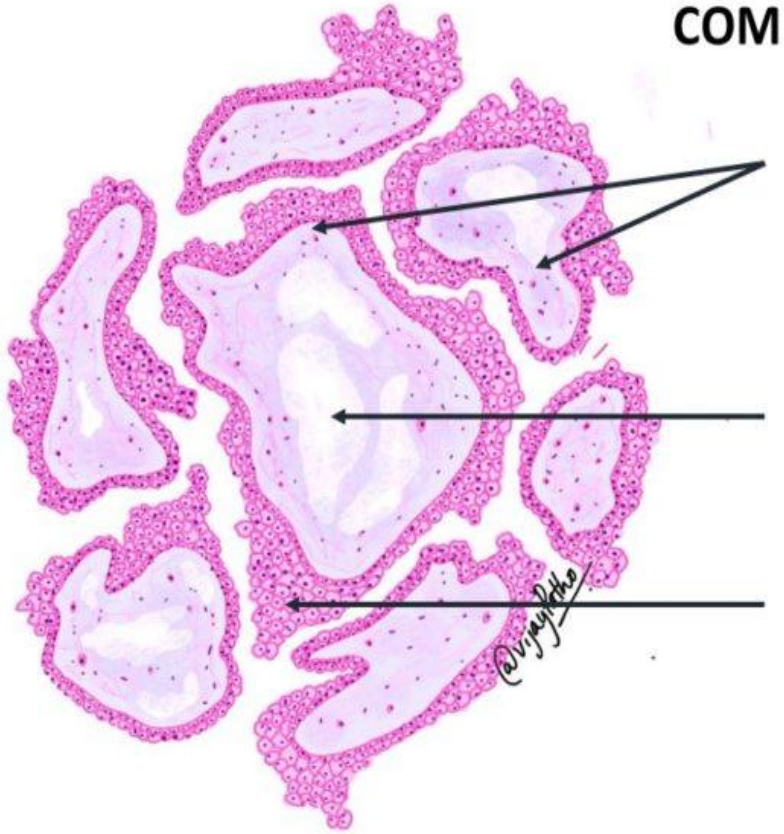
Yếu tố nguy cơ

- Dinh dưỡng kém, thiếu vitamin A, caroten
- Điều sống sống thiếu thốn
- > 40 tuổi
- Tiền căn thai trứng, sẩy thai tự nhiên


Empty ovum
23X
23X
Endoreduplication
46XX
Homozygous
Empty ovum
23X
23X
46XX
Heterozygous
Empty ovum
23X
23Y
46XY
46YY
Non-viable gamete
23X
23X
23X
69XXX
23X
23X
23Y
69XYY
23X
23X
23Y
69XXY
69YYY
Non-viable gamete



COMPLETE HYDATIDIFORM MOLE



Enlarged and dilated, edematous villi. The villi are avascular.
HYDROPIC VILLI

Cavitation / cistern

Increase in cyto and syncitiotrophoblast layers

TROPHOBLASTIC HYPERPLASIA

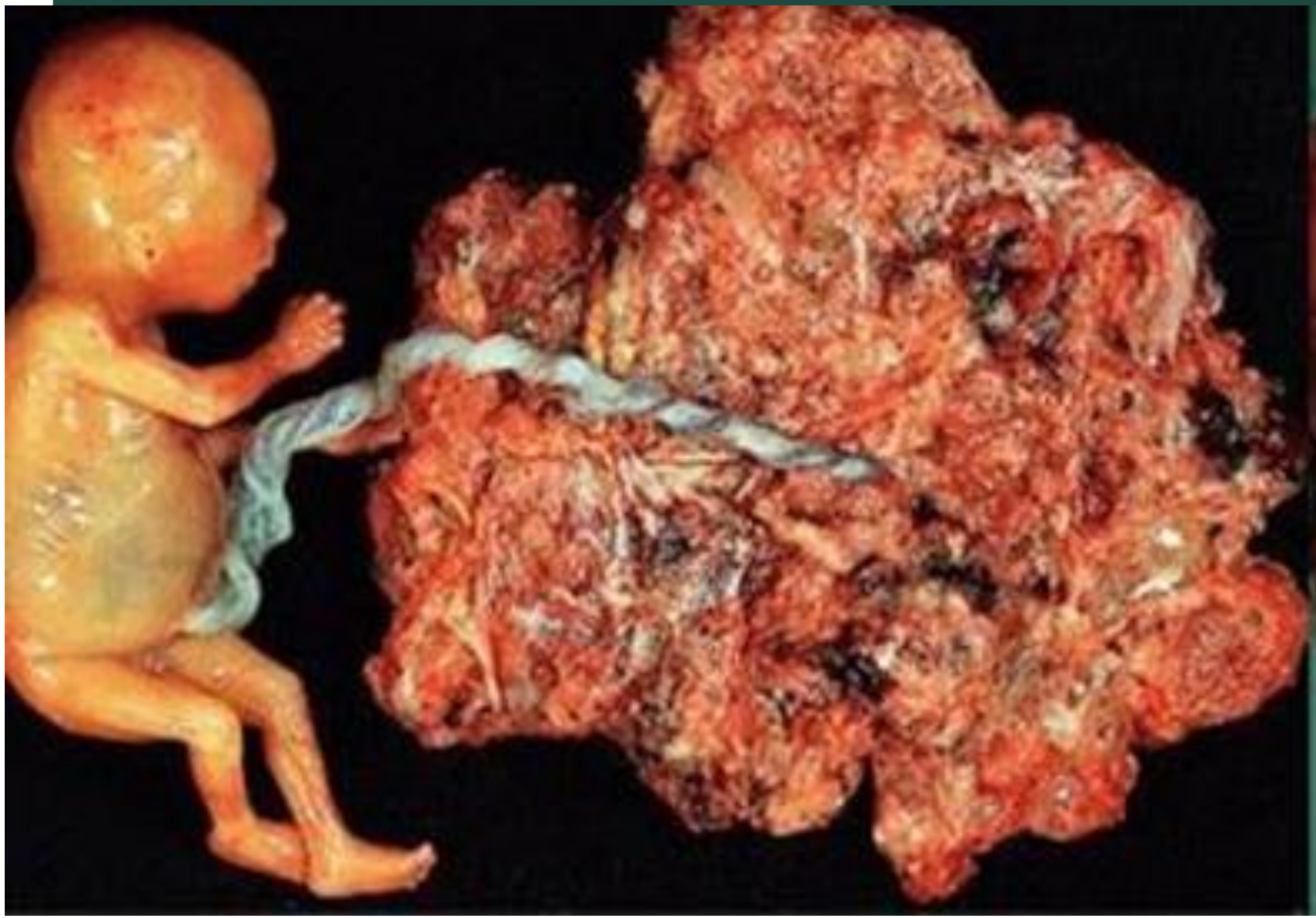
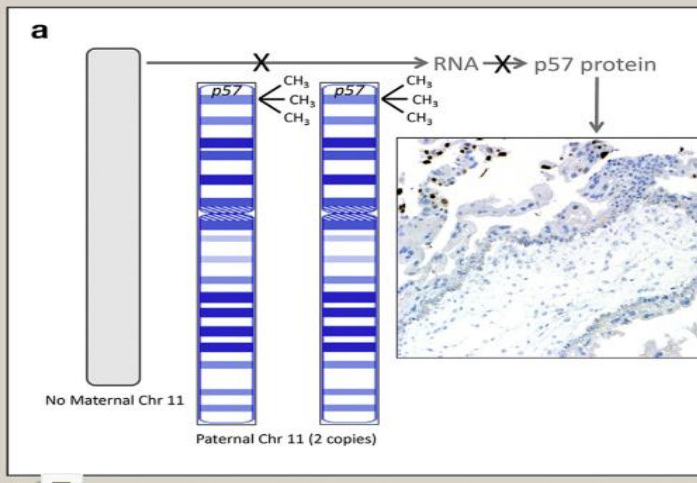




TABLE 13-2. Features of Partial and Complete Hydatidiform Moles

Feature	Partial Mole	Complete Mole
Karyotype[a]	69,XXX or 69,XXY	46,XX
Clinical presentation		
Diagnosis	Missed abortion	Molar gestation
Uterine size	Small for dates	Large for dates
Theca-lutein cysts	Rare	25–30% of cases
Initial hCG levels	<100,000 mIU/mL	>100,000 mIU/mL
Medical complications[b]	Rare	Uncommon
Rate of subsequent GTN	1–5% of cases	15–20% of cases
Pathology		
Embryo-fetus	Often present	Absent
Amnion, fetal erythrocytes	Often present	Absent
Villous edema	Focal	Widespread
Trophoblastic proliferation	Focal, slight to moderate	Slight to severe
Trophoblast atypia	Mild	Marked
$p57^{KIP2}$ immunostaining	Positive	Negative

[a]Typical karyotypes.
[b]These include anemia, hyperthyroidism, hyperemesis gravidarum, preeclampsia, and infection.
GTN = gestational trophoblastic neoplasia; hCG = human chorionic gonadotropin.



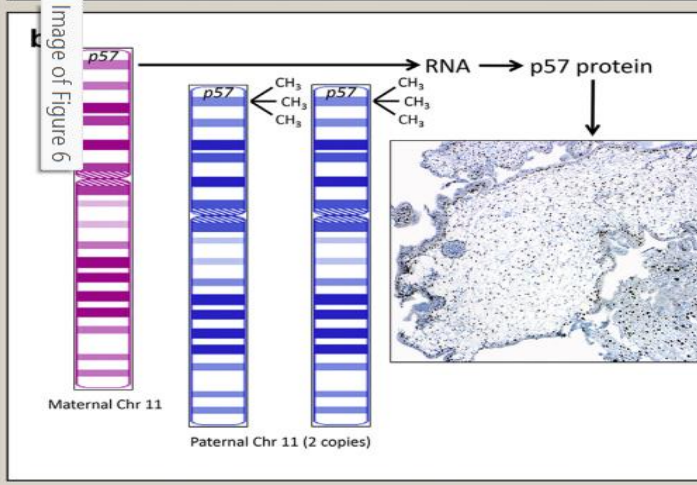
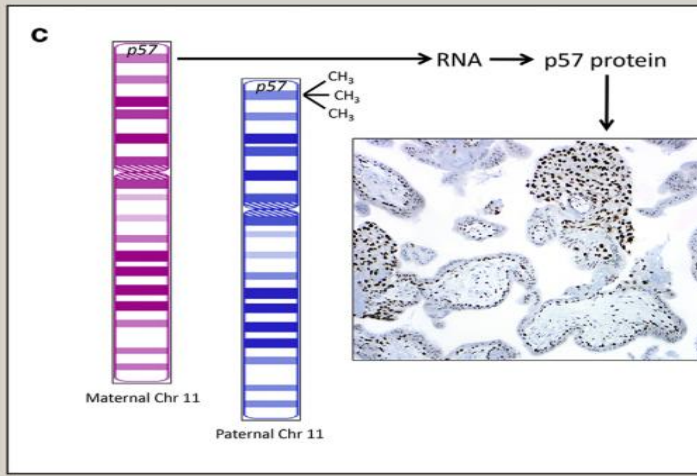


Image of Figure 6



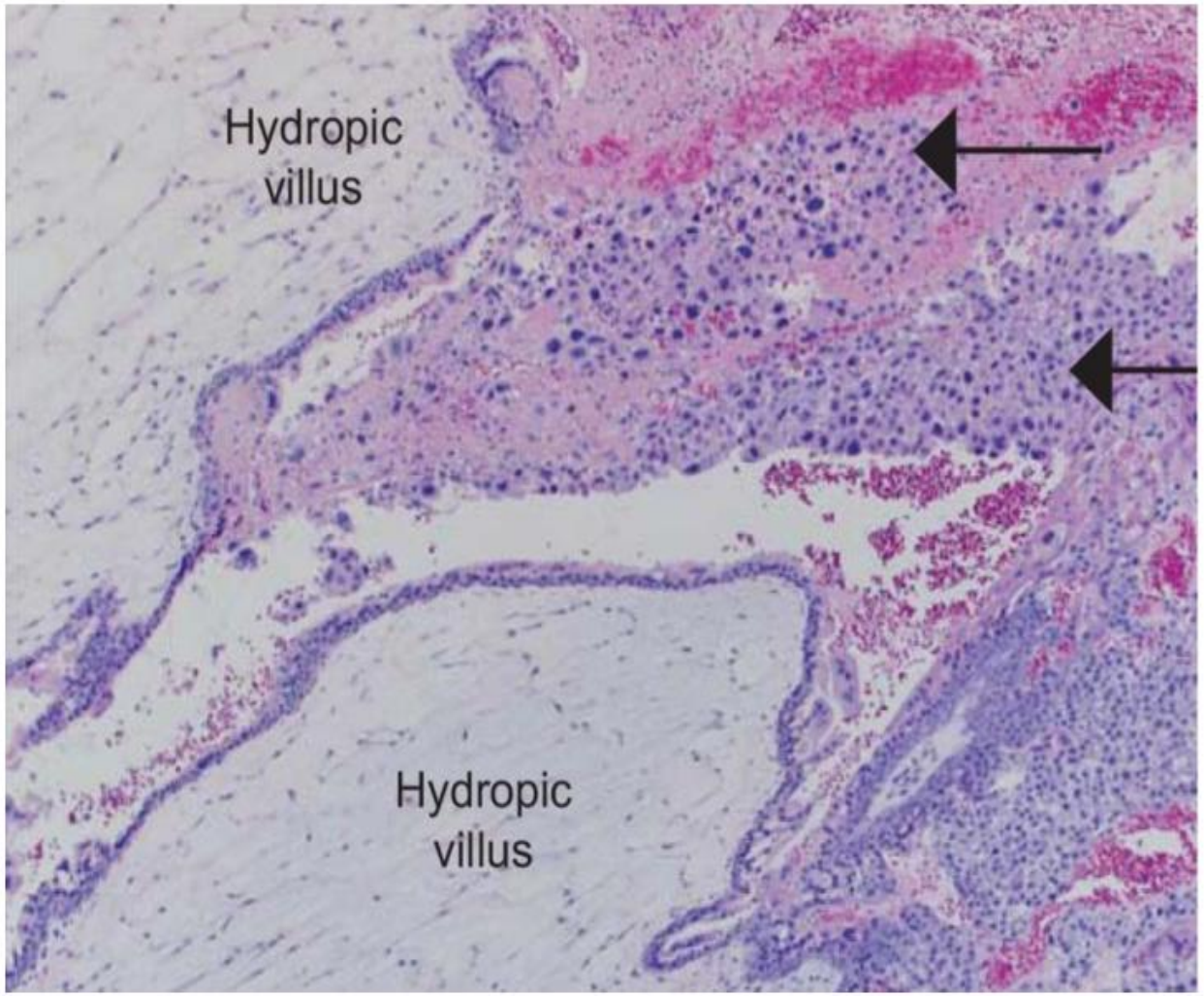


Fig. 1. Low-power photomicrograph of complete hydatidiform mole demonstrates markedly edematous avascular hydropic villi with sheets of trophoblastic cells at the periphery (*arrows*). Hematoxylin-eosin stain, ×40 magnification. Image courtesy of Dr. Siobhan M. O'Connor. Used with permission.

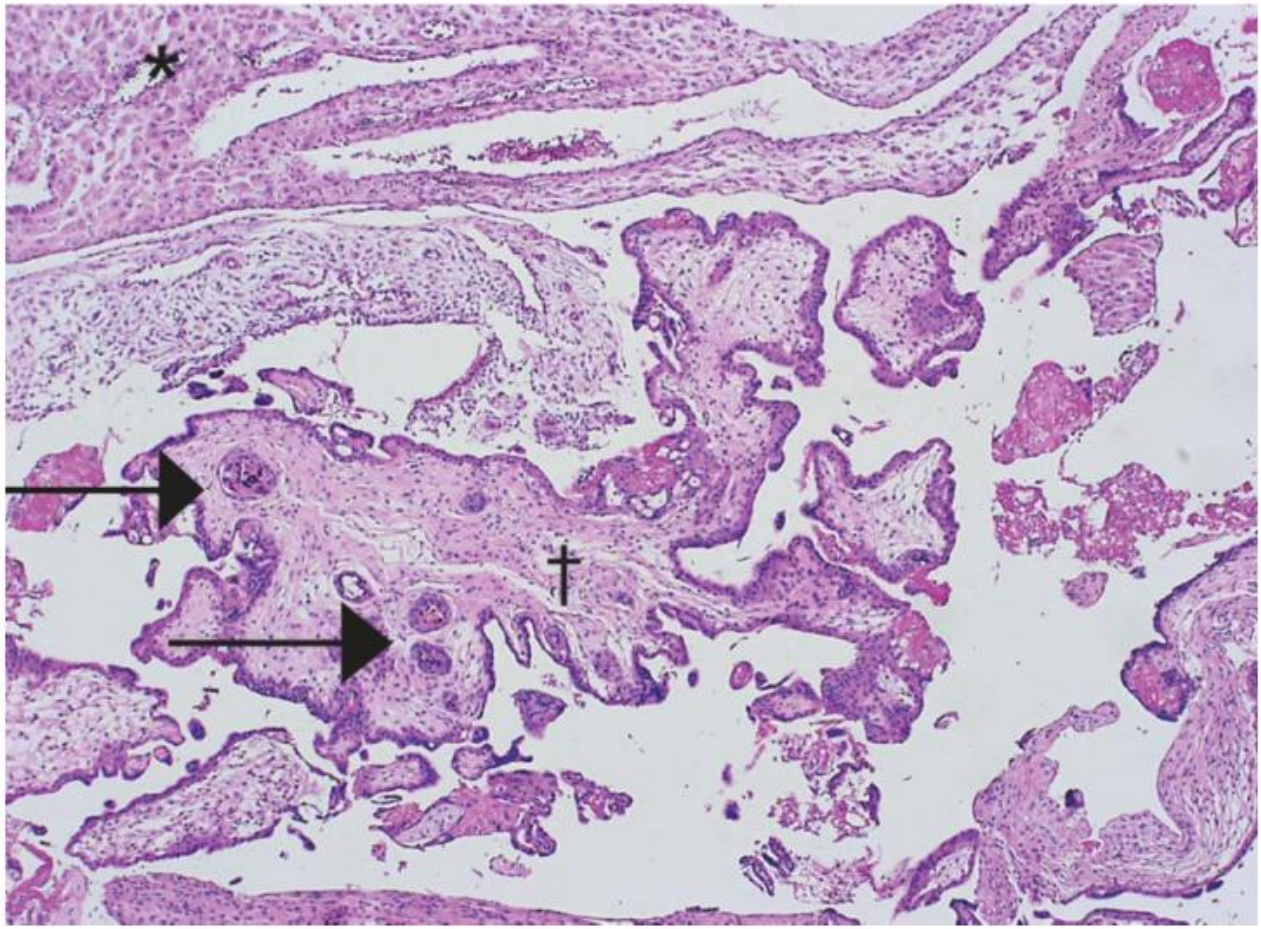


Fig. 2. Low-power photomicrograph of partial hydatidiform mole: decidualized endometrium is in the upper fiel (*), with characteristic villi centrally (†). In contrast t complete moles, there is variable edema of the villi, wit scalloping at the edges and trophoblastic inclusion (*arrows*) within villi. Trophoblastic proliferation is les pronounced and focal compared with complete moles Image courtesy of Dr. Rex Bentley. Used with permission

Triệu chứng- chẩn đoán

- Cơ năng

- Trể kinh
- Đau bụng dưới
- Rong huyết
- Tử cung to nhanh
- Nghén nặng
- Các triệu chứng do nồng độ beta-hCG quá cao: cường giáp, tiền sản giật

Triệu chứng- chẩn đoán

- Thực thể

- Thiếu máu
- Tiền sản giật (10%)
- Cường giáp (10%)
- Tử cung mềm, lớn hơn tuổi thai
- Khám âm đạo: nhân di căn âm đạo, màu tím sẫm, dễ vỡ gây chảy máu.
- Nang hoàng tuyến thường 2 bên (25-50%)

Cận lâm sàng

- Siêu âm là khảo sát đầu tay
- hCG là phương tiện theo dõi
- GPB xác nhận chẩn đoán chẩn đoán

Cận lâm sàng- siêu âm

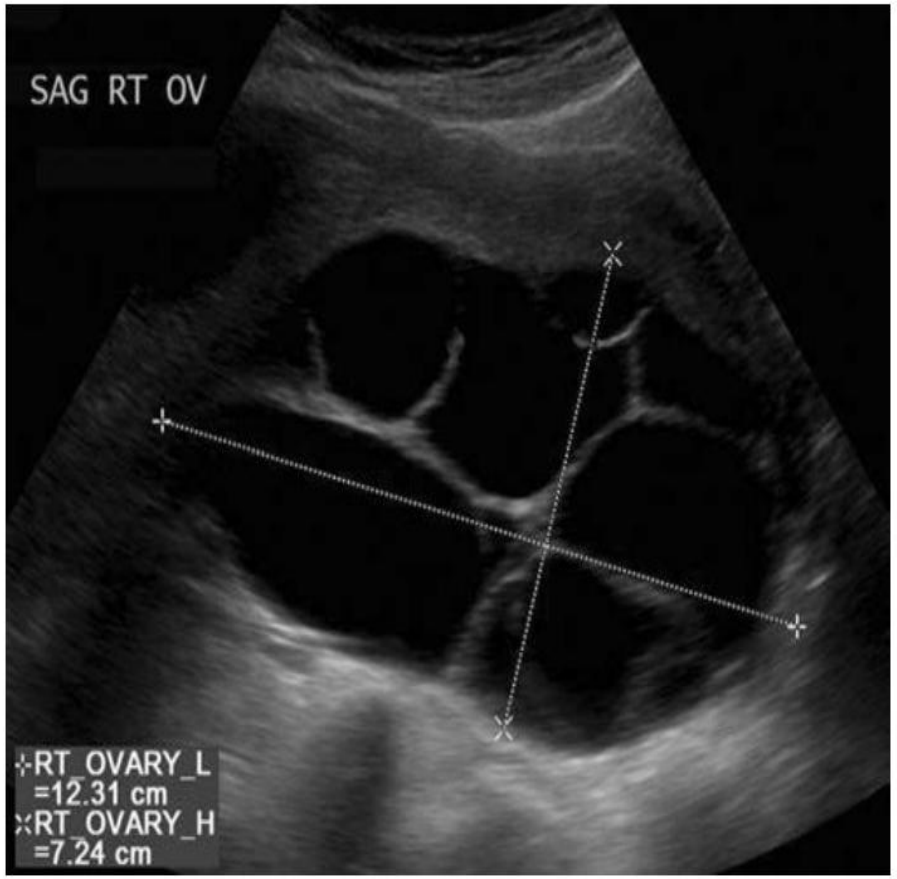
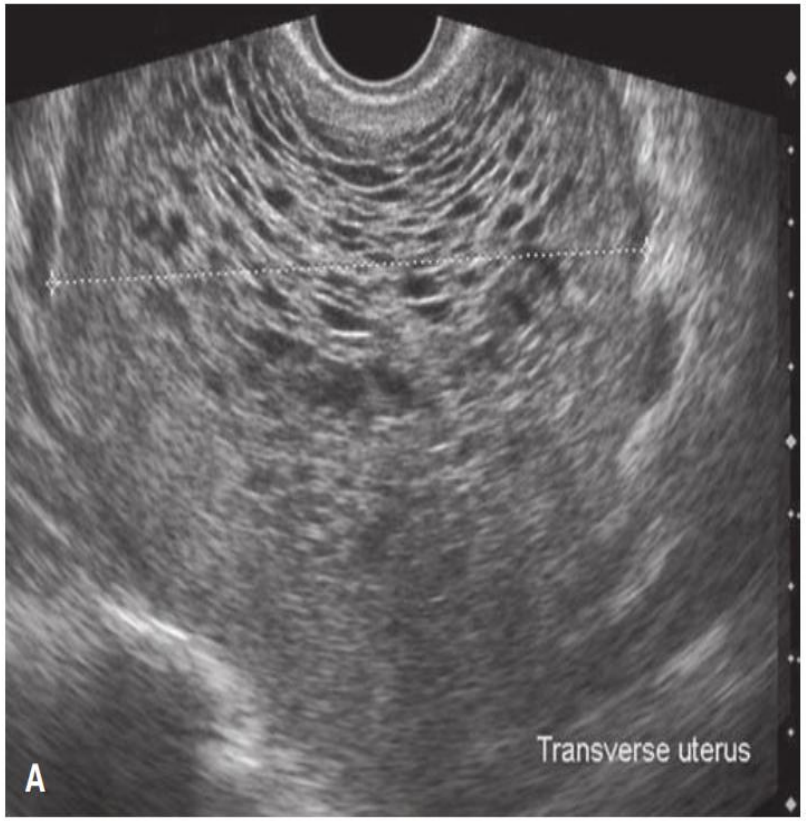


FIGURE 13-3 Sonogram of an ovary with multiple theca-lutein cysts in a woman with a complete hydatidiform mole.



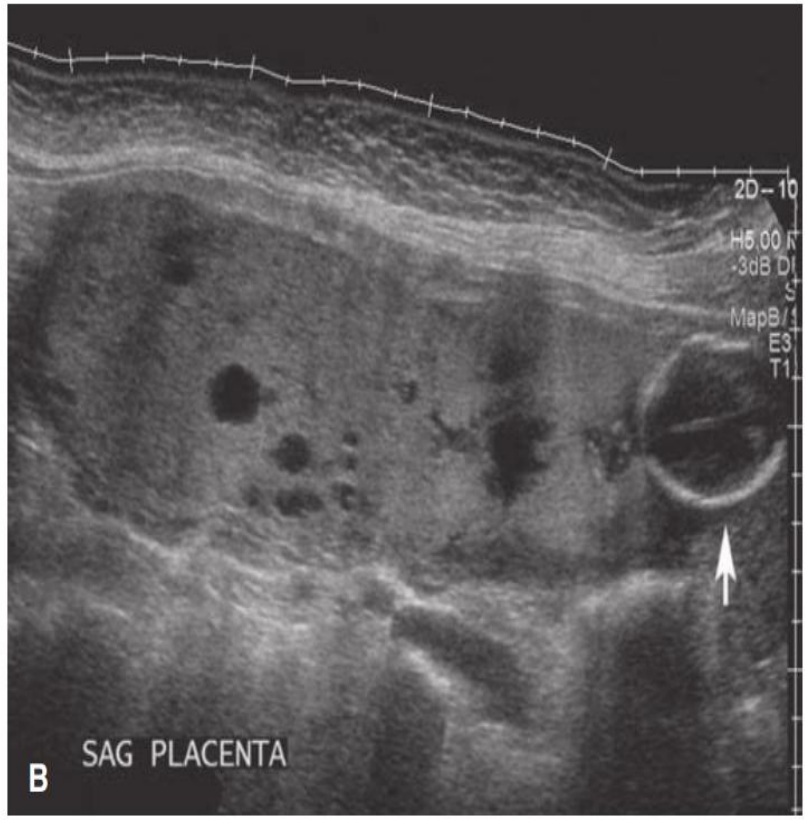


FIGURE 13-4 Sonograms of hydatidiform moles. **A.** Transverse view of a uterus with a complete hydatidiform mole. The characteristic "snow-storm" appearance reflects an echogenic uterine mass, marked by calipers, that has numerous anechoic cystic spaces. Notably, a fetus or amnionic sac is absent. **B.** In this sagittal image of a partial hydatidiform mole, the fetal head (*arrow*) lies adjacent to an enlarged, multicystic placenta.

Cận lâm sàng- ß-hCG

- ß-hCG
- Chẩn đoán và theo dõi thai trứng.
- > 100 000mUI / ml

Chẩn đoán phân biệt

- Thai ngoài tử cung: ra máu âm đạo, tử cung nhỏ , có khối cạnh tử cung đau.
- Thai chết lưu: TC nhỏ hơn tuổi thai, vú có tiết sữa non. Có thể nhầm với thai trứng thoái triển. Siêu âm giúp chẩn đoán xác định và phân biệt.
- Tử cung lớn cần phân biệt với: UXTC to; Thai to; Đa thai
- Nghén nặng trong thai thường, đa thai.

Điều trị

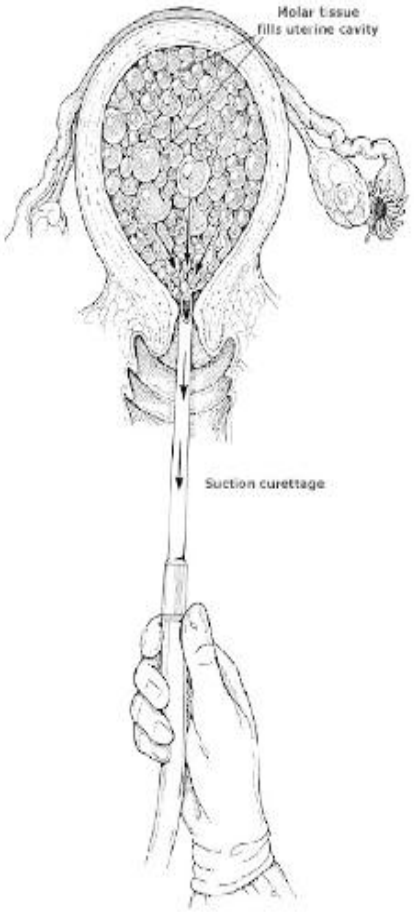
- Hút nạo thai trứng (trừ thai trứng bán phần và thai lớn)

- Điều trị vừa chẩn đoán

- Hút dưới áp lực âm

- Hút trứng + Oxytocin + kháng sinh

- Chú ý: thủng tử cung, mất máu, cơn bão giáp hoặc thuyên tắc nguyên bào nuôi.



Theo dõi

- Lâm sàng: Toàn trạng, triệu chứng nghén, triệu chứng ra máu âm đạo, sự nhỏ lại của nang hoàng tuyến và sự co hồi tử cung.
- Cận lâm sàng: Định lượng βhCG:

- **Mỗi 1 – 2 tuần** cho đến khi âm tính, sau đó 1 tháng với TTBP hay mỗi tháng trong 6 tháng với TTTP

- T**ránh thai** thời gian theo dõi (BCS, COCs, progestins)

Tiến triển

- Tiến triển tốt: 80- 90%
- Tiến triển xấu: 20% thành thai trứng xâm lấn và choriocarcinoma

Box 1 FIGO criteria for diagnosis of postmolar gestational trophoblastic neoplasia

- When the plateau of hCG lasts for four measurements over a period of 3 weeks or longer; that is, days 1, 7, 14, 21.
- When there is a rise in hCG for three consecutive weekly measurements over at least a period of 2 weeks or more; days 1, 7, 14.
- If there is a histologic diagnosis of choriocarcinoma.

CẢM ƠN LẮNG NGHE CÁC ANH CHỊ